

Fecha Última Actualización: 23-01-2023 17:33:56

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Juvenal Enrique Mardones Contreras
Edad : 82a 8m 28d
Dirección : C/ La Frontera 03493 V La Ciudad

Rut : 4.138.546-4
Fecha Nacto: 21/04/1940
Comuna : La Pintana

N° Archivo : A649426
Sexo : Masculino
Teléfono : 971727346

N° Epicrisis
338069

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 20/12/2022 10:04

Días Estadía : 29

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 18/01/2023 14:01

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

perdida de fuerza

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Juvenal Mardones Contreras
RUT: 4138546-4
Edad: 82 años
FI HSR: 20/12/2022
FI UCI: 20/12/2022
FI UTIN: 01/01/2023

Antecedentes:

- AM: HTA, DM2 NIR
- Medicamentos: Metformina
- AQx:
- Alergias: -
- Hábitos: OH niega, TBQ niega

Historia clínica:

Datos tomados de epicrisis de HPH y ficha clínica.

Paciente con antecedentes descritos, inicia con paresia Braquiocrural izquierda, desorientación y vértigo el día 17/12/2022, dado progresión de síntomas que impiden bipedestación acude a HPH el 20/12/2022. En SU al interrogatorio dirigido hija refiere conductas inhabituales como comer con la mano y no ponerse los zapatos en el lado derecho del cuerpo. Al ingreso con GCS 12 (O3V3M6), isocoria reactiva y hemipléjico a izquierda.

En HPH se realiza TC de cerebro que revela hematoma subdural crónico reagudizado por lo que se deriva a SU CASR para evaluación por neurocirugía.

En protocolo operatorio se describe evacuación cuidadosa de hematoma subdural de aspecto subagudo, sin reexpansión de parénquima cerebral. En postoperatorio inmediato evoluciona con falta de despertar pese a suspender sedación por lo que se vuelve a realizar TC de cerebro, donde impresiona hematoma subdural agudo que requiere resolución quirúrgica urgente.

En este contexto paciente es ingresada a UCI, donde evoluciona estable, con estabilidad de hematoma en controles clínicos e imagenológicos, logra vigilia y weaning hace mas de 48 horas por lo que se extuba y se decide traslado a UTINCX.

Fecha Epicrisis : 23/01/2023 17:33

Página 1 de 4

Diagnósticos de ingreso:

- Hematoma subdural crónico operado
- Evacuación de hematoma subdural subagudo
- Resangrado precoz
- Evacuación de hematoma subdural agudo
- Obs NAAS aspirativa tratada con Amp/Sulbactam (20-25/12)
- Antecedentes: DM2NIR, HTA

Paciente ingresa en regulares condiciones generales, somnoliento, desorientado, afebril, sin requerimientos de O2.

Examen físico:

SV: PA 125/58 FC 89 T 36.8 Sat 96% amb

Mucosas secas, bien perfundido a distal. Sin mottling

RR2T SS. MP + SRA.

Abdomen blando, depresible, impresiona indoloro. RHA + no palpo masas ni megalias, sin signos de irritación peritoneal.

EEII sin edema ni signos de TVP.

Neurológico:

Somnoliento, cooperador, obedece ordenes simples.

Disartría moderada

Pupilas isocóricas, reactivas, impresiona RFM disminuido a izquierda. Impresiona leve ptosis a izquierda. Corneales presentes

Hemiplejía izquierda. Fuerza al menos M3 a derecha.

Reflejo plantar izquierdo indiferente, derecho flexor.

Laboratorio de ingreso:

01/01/2023: Crea 0.56 P 2.5 Glu 156 Mg 2.1 ELP 134/4.33/102 Hto 36.4 Hb 11.5 Leu 16130 RAN 13400 RAL 1800 Plaq 405000

Planes:

·Hemodinámico: Paciente ingresa con requerimiento de DVA, NAD en dosis bajas, logrando destete. Objetivo de PA actualmente es normotension, mantengo VDO indicados desde UCI.

Actualmente con hemodinamia autosostenida. Observar

·Neurológico/ Neuroquirúrgico: Paciente con hematoma subdural crónico reagudizado, operado, con resangrado precoz que requirió nuevo drenaje.

Se mantiene con drenaje JP durante estadía en UCI, se retira 26/12 sin incidentes.

En controles imagenológicos posteriores se mantiene estable. Ultimo TC de cerebro el 28/12/2022 descrito por neurocirugía con hematoma subdural residual en reabsorción, sin crecimiento, sin mayor efecto de masa, con linea media conservada

Al ingreso paciente se encuentra somnoliento, desorientado, ultimo TC de cerebro el 28/12 y descrito como vigil en evoluciones de UCI.

Planes:

- Dado compromiso de conciencia solicito TC de cerebro de control

- Se mantiene con FAE. Evaluar NP de fenitoína en horario hábil.

- Medidas de neuroprotección

- Progresar en rehabilitación.

·Respiratorio: Intubado en contexto de patología neurológica, sin conflicto de intercambio gaseoso durante estadía. Se extuba el 28/12, con weaning exitoso por lo que se traslada a UTINCX

Actualmente sin requerimientos de O2 ni Signología respiratoria, si n conflicto actual. Apoyo con oxigenoterapia SOS.

·Infeccioso: Paciente semantuvo con cobertura empírica con ampicilina/ sulbactam por parámetros inflamatorios elevados, pero sin clínica infecciosa ni fiebre. Completando tratamiento por posible NAAS aspirativa desde el 20/12. Al ingreso afebril, sin foco infeccioso evidente pero con leucocitosis persistente con desviación izquierda. En caso de fiebre pancultivar.

·Renal: Evoluciona con función renal conservada, parámetros nitrogenados dentro de rango. Destaca Hipokalemia leve que se indico carga durante estadía en UCI.

Actualmente no es conflicto.

Fecha Última Actualización: 23-01-2023 17:33:56

Página 3 de 4

·Profilaxis: Se mantiene con protección gástrica. Dado hematoma subdural reciente se mantiene sin tromboprofilaxis, evaluar reinicio en visita con neurocirugía.

En condiciones de traslado a UTIN

EVOLUCION EN UTIN

Hemodinámico: normotensión con VDO, mantengo.

Neurológico/ Neuroquirúrgico: Paciente con hematoma subdural crónico reagudizado, operado, con resangrado precoz que requirió nuevo drenaje, retirado el 26/12 sin incidentes.

- Último TC de cerebro el 28/12/2022 descrito por neurocirugía con hematoma subdural residual en reabsorción, sin crecimiento, sin mayor efecto de masa, con línea media conservada

- Se solicitó nuevo TAC cerebro el 02/01 debido a mayor comp. de conciencia que en retrospectiva impresiona delirium, de todas formas ya está tramitado.

- Fenitoína profiláctica, ayer NP 3.1, suspendo.

Respiratorio: Curso con TOT, extubado el 28/12. Actualmente sin requerimientos de O2, sin conflicto actual.

Infeccioso: completó 5 días de AMS por sospecha de Neumonía aspirativa (FI 20/12). Cursó con nuevo peak febril, se tomaron exs el 02/1: SO inflamatorio, UC + E. Coli R a AMS y cipro, S a amika, HC 1 y 2 (-), HC arrastre CVC y periférico (-).

En suma: Impresiona ITU febril x E. Coli. Plan es completar 5 días con amikacina (FI 02/01).

Medio Interno: Con hiponatremia leve, manejada con volumen. Solicito control para mañana AM.

Profilaxis: gástrica, inicio tromboprofilaxis (autorizado por ncx)

Manejo activo. En condiciones de traslado a Sala Ncx

EVOLUCIÓN EN SALA NCX

Evoluciona estable en su condición. Episodios de desorientación, agitación en remisión. TC cerebro de control 17/01 con hematoma subdural convexidad derecha en proceso de cronificación, con surcos conservado en contexto de atrofia cerebral conocida. Exs de lab 10/01/23: creat 0.54, BUN 13, PCR 41, Na 135, K 4.5, HB 11.5, GB 10660, UC (-). Exámenes de control 23/01: Hb 12.3, GB 7810, crea 0.59, BUN 13, PCR 44. Al ex actual paciente en buenas cond generales, vigil, desorientado, inatento, obedece ordenes simples, isocoria reactiva bilateral, y moviliza 4 ees. En lo kinesiológico con regular control de tronco. En lo fonoaudiológico eventual retiro de SNG.

Se decide alta con hosp domiciliaria para continuar rehab, y control ambulatorio con nueva neuroimagen.

Diagnóstico de Egreso

Traumatismo Intracraneal -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Al ex actual paciente en buenas cond generales, vigil, desorientado, inatento, obedece ordenes simples, isocoria reactiva bilateral, y moviliza 4 ees.

Plan Post Alta

- Reposo relativo, levantar asistida en la medida que progrese rehabilitación
- Régimen por SNG, en proceso de eventual retiro, se complementa con reg oral progresivo.
- Kinesiológico: sentar borde cama, bipedestear y caminar asistido
- Paracetamol 1 gr c/ 8 hrs SOS si dolor
- Enoxaparina 40 mg SC al día
- Atorvastatina 40 mg/noche x SNG/VO
- Carvedilol 6.25mg c/12hrs x SNG/VO

Fecha Epicrisis : 23/01/2023 17:33

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 23-01-2023 17:33:56

Página 4 de 4

- Hidralazina 100 mg c/8 hrs x SNG/VO
- Isosorbide 10 mg c/ 8 hrs x SNG/VO
- Omeprazol 20 mg/día x SNG/VO
- Quetiapina 50 mg en la noche (+ 25 mg AM SOS) por SNG/VO
- Realizar TC cerebro de control en 10 días, se adjunta orden (solicitar hora en CDT)
- Control ambulatorio con Neurocirugía en 2 semanas, solicitar hora con esta epicrisis en CDT pasillo 9. Asistir con TC realizado
- Consulta SOS en urgencias si signos de alarma

Indicaciones

Tipo de Reposo :

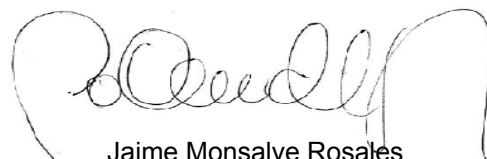
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Felipe Andrés Cifuentes Fernández
Becado/Residente



Jaime Monsalve Rosales
Médico Tratante (Staff)